Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS SUR PRESCRIPTION ANTICIPÉE — ARTICLE R.4311-6 (2°) CSP

Agitation / confusion aiguë : bilan IDE

EHPAD, MAS/FAM (plan de crise individuel), IME · bilan d'abord, psychotrope ensuite

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · signes d'AVC, trouble de conscience brutal, détresse respiratoire, convulsion ; fièvre sous neuroleptique (raideur) ; hypoglycémie non corrigée ; danger immédiat.

J'applique si

- Agitation, agressivité, cris **inhabituels** ou brutaux ; confusion **fluctuante**.
- Non communicant : **changement brutal de comportement**.

Je ne fais pas

- Donner un « si besoin » **avant le bilan**.
- Psychotrope **non prescrit** ou dose en plus sans prescription écrite.
- **Contention** : jamais sur ce protocole (prescription médicale motivée).

J'agis

RÔLE PROPRE

1. **Sécurité** : distance, objets retirés, autres à l'abri ; calme ; plan de crise individuel s'il existe.
2. Bilan : **glycémie**, SpO2, T°, PA, FC, FR, FAST ; **douleur** (Algoplus, EDAAP…).
3. **Globe** (bladder scan), BU ; médicament récent ou **sevrage** (BZD, alcool, tabac).
4. Douleur : **paracétamol** (son protocole) ; boire, toilettes.

SUR CE PROTOCOLE

5. **Toucher rectal** si fécalome suspecté (protocole « Fécalome – Toucher rectal, extraction, lavement »).
6. « **Si besoin** » prescrit : exactement molécule, dose, critère, maximum/24 h.

SUR AVIS MÉDICAL

7. Psychotrope non prescrit, dose en plus, contention, sondage d'un globe.

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

Confusion ? (CAM)

Début brutal ou fluctuant

+ inattention

+ désorganisation ou vigilance altérée

- = confusion aiguë : chercher une cause somatique, avis le jour même

J'appelle le médecin

- Toute **confusion aiguë** : avis **le jour même** (sans délai si signe de gravité).
- « Si besoin » sans effet ou répété ; globe, fécalome, BU +, médicament suspect.
- Sous hydroxyzine ou BZD longue (âgé) : en parler (fiche « Anxiolyse en ESMS »).

Je surveille et je trace

- Comportement, vigilance, constantes ; déclencheurs, bilan, mesures ; effet du « si besoin » (chute, FR).
- Nuit sans IDE : « si besoin » par l'AS/AES après **validation IDE** seulement.

À retenir : Une agitation aiguë est somatique jusqu'à preuve du contraire : bilan d'abord, psychotrope ensuite, contention seulement sur prescription.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : HAS, Confusion aiguë chez la personne âgée : prise en charge initiale de l'agitation (2009) ; ANAES, Limiter les risques de la contention physique de la personne âgée (2000) ; HAS-ANESM, Les comportements-problèmes (2016) ; ARS IDF/SGGIF 2016 et ARS IDF/STARAQS 2023, fiches agitation ; Inouye, CAM (1990) ; arrêté du 26/06/2026, art. 1 et 4 II ; fiche DOTR « Anxiolyse en ESMS ».

Réf. DOTR-IDE-AGIT | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature